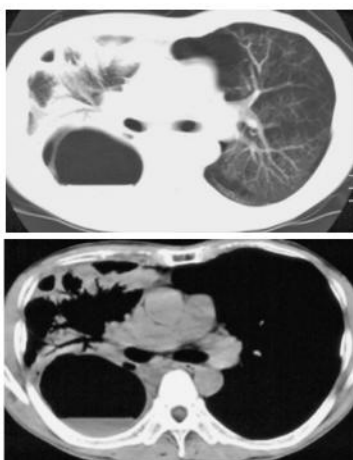
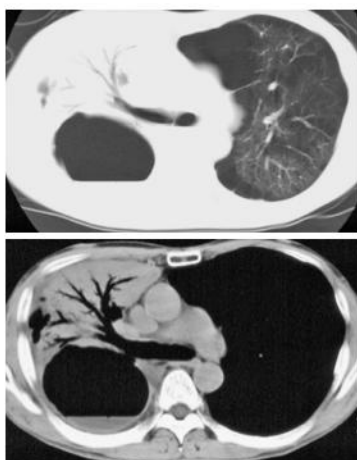




a.

b.

図3 肺膿瘍の画像所見 3

a: 胸部X線写真, b: 胸部CT

3歳 男性

併存疾患: 肺気腫, 肺嚢胞

原因菌: *M. avium*

剤を選択する。嫌気性菌へのスペクトラムを有するβラクタム系内服抗菌薬としては amoxicillin/potassium clavulanate があり、キノロン系薬では ciprofloxacin, garenoxacin, moxifloxacin が嫌気性菌にも有効である。

ii) 治療期間

抗菌薬の投与期間はいまだ議論中であるが、3週間でよい場合もあれば、8週以上の治療が必要である場合もある。経験的には、画像所見上、病変部位が消失、あるいは縮小かつ残存病変が安定化するまでは抗菌治療を継続したほうがよい⁸⁾。

iii) 治療の反応

通常、抗菌薬に反応し経過がよい場合は3~4日後に解熱などの徴候がみられるが、改善傾向が乏しい場合は、画像所見などを再確認のうえ、気管支鏡検査などで原因微生物を再検索し、鑑別疾患として非感染性疾患〔気管支閉塞、悪性腫瘍、血管炎（多発血管炎性肉芽腫症）など〕も考慮したほうがよい。

iv) 侵襲的治療

7~10日程度の抗菌治療に反応が乏しい場合は、膿瘍のドレナージや外科手術が必要になることがある。

iv-1) カテーテルドレナージ

通常、持続的なドレナージを要するためビッグテールカテーテルなどの留置が行われる。穿刺に伴う気胸のリスクがあるため、処置前にCTや超音波検査を実施して穿刺の位置を慎重に検討する。胸壁に近ければX線やCT透視下で経皮的に行い、中枢側に病変がある場合は、エコーガイド下で気管支鏡を用いてカテーテルを留置する方法もある。

iv-2) 外科治療

気管支閉塞、直径6 cm以上の巨大膿瘍を有する場合、あるいはカテーテルによるドレナージが難しい場合は、外科手術による治療介入を検討する。

b) 予後

本疾患75名の後向き研究では、死亡割合は約20%と報告されている⁹⁾。基礎疾患、免疫不全を伴う場合は死亡割合がさらに高くなる。

Advanced

■免疫不全患者での肺膿瘍

免疫不全患者では、表1に示したように抗酸菌、真菌などの多くの日和見病原体が類似した疾患を引き起こす。原因微生物の検索では、コンタミネーションの確率が低い検体での評価が望まれ、また組織診断も鑑別に有用であるため気管支鏡検査を早めに行うことが望ましい。

文 献

- 1) Chung G, et al : Curr Infect Dis Rep 2 : 238, 2000
- 2) Bartlett JG : Anaerobe 18 : 235, 2012
- 3) Takayanagi N, et al : Respiration 80 : 98, 2010
- 4) Bartlett JG : Chest 91 : 901, 1987
- 5) Mori T, et al : Intern Med 32 : 278, 1993
- 6) Menzies SM, et al : Thorax 66 : 658, 2011
- 7) Shindo Y, et al : Respiriology 22 : 1536, 2017
- 8) Bartlett JG : Clin Infect Dis 16(Suppl 4) : S248, 1993
- 9) Hirshberg B, et al : Chest 115 : 746, 1999